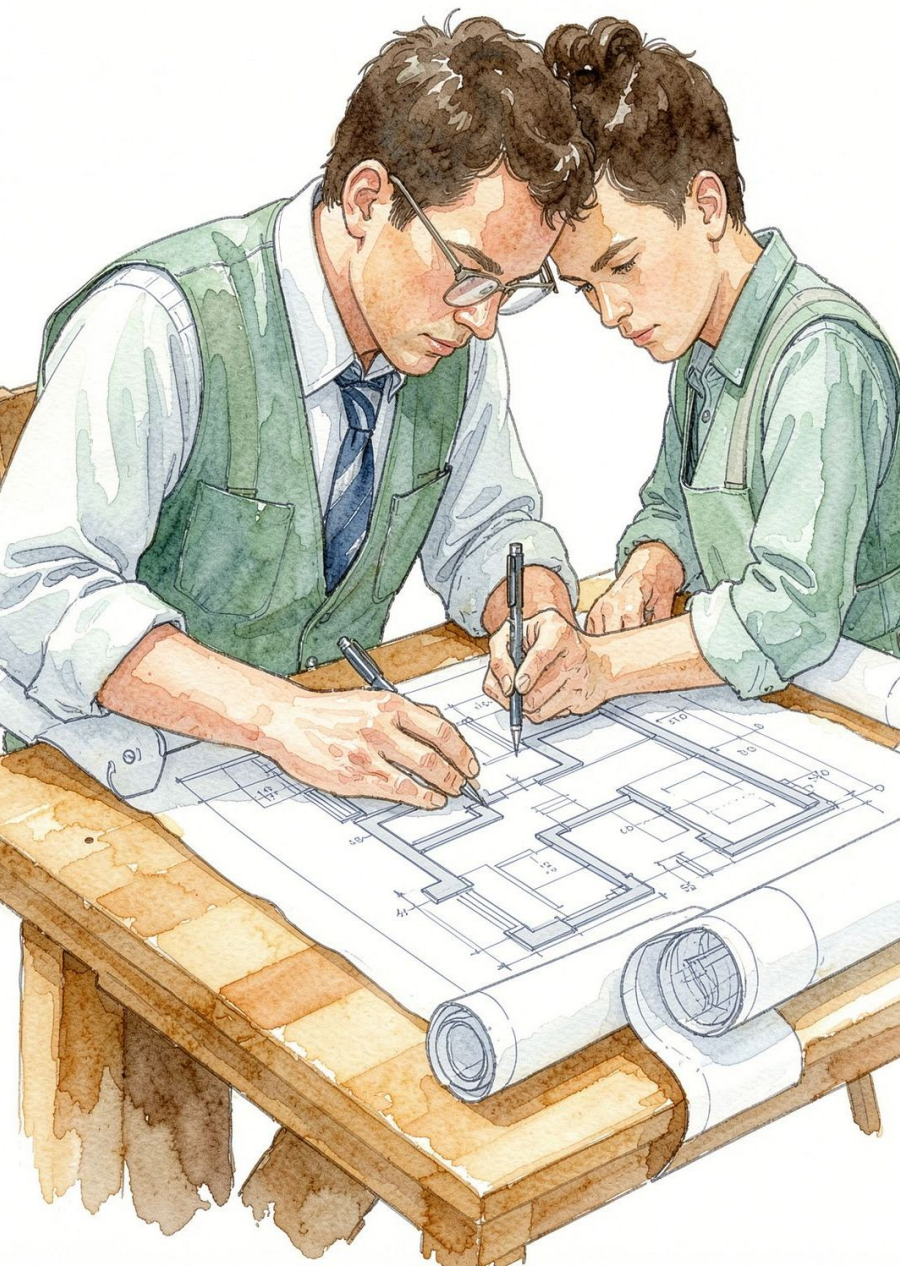




Más allá del Prisma

Programa de Formación para Profesionales · Taller 1

Desarrollo didáctico: Caso Clínico y aplicación en la Clínica de la Convergencia



El Arquitecto sin Trazos: Presentación del Caso

Bernardo, 45 años

Arquitecto de prestigio. Dos años de bloqueo creativo absoluto tras la quiebra fraudulenta de su estudio y la pérdida de su socio.

Presentación clínica

- Postura encorvada, mirada fija, tono monocorde
- Anhedonia severa y aislamiento hermético

"Ya no hay imágenes, doctor; mi cabeza es un depósito de escombros grises."

Diagnóstico Previo vs. Lectura Convergente

1

Enfoque Biologista

Trastorno depresivo mayor → ISRS +
activación conductual

2

Hermenéutica Clásica

Traición del socio como reactivación de
la ambivalencia edípica

3

Clínica de la Convergencia

Articula los planos pluridimensionales
— neurobiológico, metapsicológico y
vincular — sin reduccionismos

Colapso del Sistema Alostático y la DMN



Eje HPA en alerta crónica

El trauma mantuvo el sistema simpático activado de forma permanente, inhibiendo la Red de Modo por Defecto.

Secuestro prefrontal

Las áreas prefrontales quedaron capturadas por la descarga amigdalina: sin espacio para la ensoñación ni el proceso primario.

Resultado

El cerebro operaba en modo de supervivencia estricta — **la mente se volvió un búnker.**

Pérdida del Objeto Sublimatorio

La arquitectura como dique

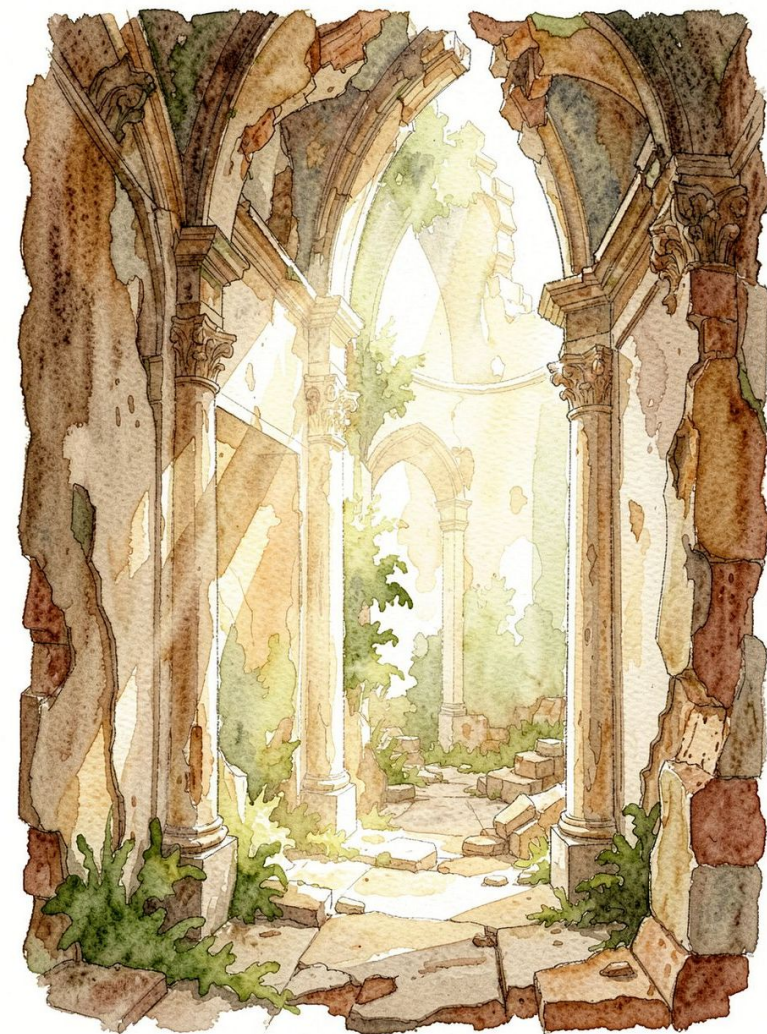
Era el dique sublimatorio primordial de Bernardo: a través de la forma ligaba fantasmas de precariedad y desamparo temprano.

El socio como soporte

Funcionaba como soporte especular y transferencial narcisístico — un espejo que sostenía la identidad creadora.

El derrumbe total

Al perder ambos, se desmoronó no solo la economía material sino el **andamiaje metapsicológico completo.**



Herramientas de Intervención Convergente



Descompresión Autonómica

Revisión farmacológica para reducir hiperreactividad amigdalina sin apagar la claridad asociativa.

Presencia continente y baja exigencia interpretativa.



Puente Kinestésico

Abandono temporal del diseño digital. Trabajo con lápices blandos, papel de estraza y maquetas de cartón para recuperar el contacto cinestésico con el trazo.



Interpretación de la Fractura Narcisística

Señalar cómo los sueños (puentes rotos, laberintos) intentaban dar volumen a la traición. El plano ya no como monumento a la perfección, sino como espacio capaz de alojar la grieta.



Desenlace Clínico

Bernardo trajo un cuaderno de bocetos con **trazos oscuros, texturas rugosas y volúmenes asimétricos** — estudios sobre cómo la estructura se sostiene a pesar de una fractura central.

Descarga emocional

Al apoyar los bocetos sobre el escritorio, experimentó un llanto profundo y liberador.

Reconexión de la DMN

La red de modo por defecto reconectó con los centros ejecutivos: la energía pulsional encontró nuevamente el cauce de la sublimación.

La Potencia de la Clínica de la Convergencia

Al articular la hondura de la metapsicología con la materialidad de la neuropsicología, la Clínica de la Convergencia posee las herramientas precisas para **devolverle al sujeto la potencia creadora de su deseo.**

Más allá del reduccionismo

Trasciende tanto el enfoque biológico como el hermenéutico, integrando ambas dimensiones sin jerarquías.

Acción simultánea

Actúa en simultáneo sobre el vínculo transferencial, la modulación afectiva y el apronte somático.

El retorno del trazo

La arquitectura volvió a ser el puente entre el mundo interno desolado y la alteridad del lazo social.

